



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:21

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 33153693 - ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

Fecha de Nacimiento: 22/10/1955

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO LA GLORIA CALLE 26 B # 46 - 64

Teléfono: 3135991668

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: LINA PUELLO

Teléfono Acomp.: 3024259732

Dirección Acomp.: MSMA DIRECCION

Responsable:

Teléfono Resp.: 3024259732

Dirección Resp.:

Médico Tratante: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO

Administradora: NUEVA EPS

Fecha de Atención: 31/05/2022 07:48

Admisión: AD736482

Edad: 66 año(s), 7 mes(es) 9 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: HIJA

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: FCAMACHO

Sexo: F

Estado Civil: Casado

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 11/05/2022 11:38

Cama: CM788

Motivo de la Consulta:

"ESTA CON TOS"

ANTECEDENTES:

XXXXXX

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE DE 66 AÑOS DE EDAD SIN ANT DE IMPORTANCIA INGRESA CON CC DE LARGA DATA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA CON EXPECTORACION HEMATICA EN EL DIA DE HOY. AL INT PACIENTE INIEGA FIEBRE, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR. AL EF PACIENTE ORIENTADO, ALERTA, CONCIENTE, NO AGREGADOS CARDIOPULMONARES. SIGNOS VITALES EN METAS.

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, SE INICIO TERAPIA RIPE, HASTA AL MOMENTO TOLERANDO TERAPIA, SIN COMPROMISO HEPATICO O RENAL POR LO QUE SE DA EGRESO CON TERAPIA RIPE, CITA CONTROLES Y SIGNOS DE ALARMY RECOMENDACIONES SE INDICA INICIAR EN PROGRAMA DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS, RECLAMAR CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM AMBULATORIO., SE EXPLICA A PACIENTE, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Revisión Por Sistema:

NO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

ORIENTADO, ALERTA, CONCIENTE

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, NO LESIONES, CUELLO SIMETRICO SIN MASAS NI ADENOPATIAS

Tórax:

SIMETRICO EXPANSIBLE SIN TIRAJES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL DISMINUIDO

Abdomen:

BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO, NO MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL

Piel y faneras:

NO PALIDEZ, NO ICTERICIA, NO HERIDAS, NO ULCERAS POR PRESION

Genito-Urinario:

_ NORMOCONFIGURADO PARA EDAD Y SEXO

Extremidades:

SIMETRICAS EUTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD

Sistema nervioso central:

SIN DEFICIT APARENTE MOTOR NI SENSITIVO, CONCIENTE, ALERTA, ORIENTADO, GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE DE 66 AÑOS DE EDAD SIN ANT DE IMPORTANCIA INGRESA CON CC DE LARGA DATA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA CON EXPECTORACION HEMATICA EN EL DIA DE HOY. AL INT PACIENTE INIEGA FIEBRE, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR. AL EF PACIENTE ORIENTADO, ALERTA, CONCIENTE, NO AGREGADOS CARDIOPULMONARES. SIGNOS VITALES EN METAS.

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

Diagnóstico Principal:

J180 : BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1:

R042 : HEMOPTISIS

EVOLUCIONES:

Fecha: 11/05/2022: 16:35:25, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: YOCIMAR FLOREZ MUÑOZ, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: EVOLUCION

Descripción: GLUCO 84, CRE 0.72, PCR 2.1, CL 103, K 3.7, NA 140, , LEUCO 6.91, NEURO 75.5, LINF 13.0. HB 11.7, HCT 39.3. VCM 91.9, HCM 27.4, CCMH 29.8, PLT 346 PACIENTE QUE SE REVALORA CON RESULTADOS DE PARACLINICOS LOS CUALES MUESTRA HEMOGRAMA, SIN LEUCOSIS CON NEUTROFILIA, HEMOGLOBINA CON LEVE ANEMIA HEMOGLOBINA SIN ANTERACION, SE CONSIDERA REALIZA IMAGINES DIAGNOSTICA PARA TOMA DE CONDUCTA FINAL SE ESTA ATETO A VARIABLE CLINICA

Fecha: 11/05/2022: 22:27:15, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: GERALDINE LUCIA RUIZ PASTRANA, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: NOTA EVOLUCION

Descripción: PACIENTE DE 66 AÑOS DE EDAD SIN ANT DE IMPORTANCIA INGRESA CON CC DE LARGA DATA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA CON EXPECTORACION HEMATICA EN EL DIA DE HOY. AL INT PACIENTE NIEGA FIEBRE, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR. AL EF PACIENTE ORIENTADO, ALERTA, CONCIENTE, NO AGREGADOS CARDIOPULMONARES. SIGNOS VITALES EN METAS. GLUCO 84, CRE 0.72, PCR 2.1, CL 103, K 3.7, NA 140, , LEUCO 6.91, NEUTRO 75.5, LINF 13.0. HB 11.7, HCT 39.3. VCM 91.9, HCM 27.4, CCMH 29.8, PLT 346 TAC DE TORAX TAC DE TORAX: Se realiza estudio en equipo multidetector mediante cortes secuenciales axiales desde la entrada torácica hasta el nivel de los diafragmas. Se obtuvo registro con ventana para pulmón y mediastino. El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares basales bilaterales con areas de opacidad alveolar difusas y cavitaciones por proceso inflamatorio cronico de origen granulomatoso . La vascularización pulmonar no presenta alteraciones. No hay evidencia de derrame ni engrosamiento pleural. La silueta cardiaca es de tamaño y configuración normales. Los grandes vasos son de calibre, disposición y apariencia usuales. El calibre de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios lobares y segmentarios es adecuado, no hay áreas de estrechez ni compresión extrínseca. El esófago es de paredes delgadas. No hay evidencia de adenomegalias en las diferentes estaciones ganglionares. La caja torácica no muestra alteraciones. POR LO QUE SE SOLICITA VALORACION POR MEDICINA INTERNA

Fecha: 11/05/2022: 22:27:19, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: GERALDINE LUCIA RUIZ PASTRANA, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: NOTA EVOLUCION

Descripción: PACIENTE DE 66 AÑOS DE EDAD SIN ANT DE IMPORTANCIA INGRESA CON CC DE LARGA DATA DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA CON EXPECTORACION HEMATICA EN EL DIA DE HOY. AL INT PACIENTE NIEGA FIEBRE, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR. AL EF PACIENTE ORIENTADO, ALERTA, CONCIENTE, NO AGREGADOS CARDIOPULMONARES. SIGNOS VITALES EN METAS. GLUCO 84, CRE 0.72, PCR 2.1, CL 103, K 3.7, NA 140, , LEUCO 6.91, NEUTRO 75.5, LINF 13.0. HB 11.7, HCT 39.3. VCM 91.9, HCM 27.4, CCMH 29.8, PLT 346 TAC DE TORAX TAC DE TORAX: Se realiza estudio en equipo multidetector mediante cortes secuenciales axiales desde la entrada torácica hasta el nivel de los diafragmas. Se obtuvo registro con ventana para pulmón y mediastino. El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares basales bilaterales con areas de opacidad alveolar difusas y cavitaciones por proceso inflamatorio cronico de origen granulomatoso . La vascularización pulmonar no presenta alteraciones. No hay evidencia de derrame ni engrosamiento pleural. La silueta cardiaca es de tamaño y configuración normales. Los grandes vasos son de calibre, disposición y apariencia usuales. El calibre de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios lobares y segmentarios es adecuado, no hay áreas de estrechez ni compresión extrínseca. El esófago es de paredes delgadas. No hay evidencia de adenomegalias en las diferentes estaciones ganglionares. La caja torácica no muestra alteraciones. POR LO QUE SE SOLICITA VALORACION POR MEDICINA INTERNA

Fecha: 12/05/2022: 10:50:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR.

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA HEMOPTISIS, REFIERE TOS, NIEGA FIEBRE U OTROS SINTOMAS

Objetivo:

SIGNOS VITALES: FC: 70 FR: 16 TA: 110/80 T: 37 SO2: 99

PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NASALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREGADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

PARACLINICOS

TOMOGRAFIA DE TORAX CON CAVITACIONES APICALES.

PENDIENTE PERFIL HEPATICO, PENDIENTE CULTIVO Y GEN EXPERT, PENDIENTE BACILOSCOPIAS

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMAGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO, VIA AEREA PERMEABLE. CON EXAMEN FISICO NORMAL EN LOS PARACLINICOS DE INGRESO SIN ALTERACIONES, HOSPITALIZADA EN SALA DE DE INFECTOLOGIA CON AISLAMIENTO RESPIRATORIO A LA ESPERA DE BACILOSCOPIA PRIMERA NEGATIVA, SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 13/05/2022: 10:01:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA HEMOPTISIS, REFIERE TOS, NIEGA FIEBRE U OTROS SINTOMAS, LA PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE Y REFIERE SENTIRSE MEJOR.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: FC: 84 FR: 18 TA: 118/80 T: 37 SO2: 98 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPECUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS TOMOGRAFIA DE TORAX CON CAMTACIONES APICALES. PENDIENTE PERFIL HEPATICO, PENDIENTE CULTIVO Y GEN EXPERT, PENDIENTE BACILOSCOPIAS

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, PRESENTA EXAMEN FÍSICO NORMAL EN LOS PARACLINICOS DE INGRESO SIN ALTERACIONES, AL DÍA DE HOY SE RECIBE REPORTE DE PRUEBA VIH QUE SE EVIDENCIA NEGATIVA, NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE REPORTE FINAL DE CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, LA PACIENTE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN SALA DE DE INFECTOLOGIA CON AISLAMIENTO RESPIRATORIO, SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 14/05/2022: 08:42:18, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA HEMOPTISIS, REFIERE TOS, NIEGA FIEBRE U OTROS SINTOMAS, LA PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE Y REFIERE SENTIRSE MEJOR.

Objetivo:

FC: 84 FR: 18 TA: 118/80 T: 37 SO2: 98 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPECUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS TOMOGRAFIA DE TORAX CON CAMTACIONES APICALES.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, CONTINUA EN HOSPITALIZACION PENDIENTE VALORACION POR INFECTOLOGIA

Fecha: 15/05/2022: 09:08:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR.

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA NUEVOS EPISODIOS DE HEMOPTISIS

Objetivo:

FC: 90 FR: 14 TA: 120/70 T: 36 SO2: 98 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPECUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, PACIENTE CON BACILOSCOPIAS NEGATIVAS, A LA ESPERA DE CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM Y GEN EXPERT, PENDIENTE VALORACION POR INFECTOLOGIA CRITICA PARA DEFINIR INICIO DE TERAPIA ANTIFIMICA, CONTINUA EN HOSPITALIZACION.

Fecha: 16/05/2022: 11:19:13, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA DE LAS SINTOMATOLOGIAS, NIEGA FIEBRE Y OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

FC: 83 FR: 16 TA: 120/70 SO2: 95 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, PACIENTE CON BACILOSCOPIAS NEGATIVAS, VALORADA POR INFECTOLOGIA QUIEN CONSIDERA VALORACION POR NEUMOLOGIA SIN INICIO DE TERAPIA ANTIFIMICA

Fecha: 17/05/2022: 09:54:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA DE LA DISNEA, NIEGA FIEBRE, NAUSEAS VOMITOS Y OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

FC: 76 FR: 19 TA: 104/87 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA A LA ESPERA DE VALORACION POR NEUMOLOGIA

Fecha: 18/05/2022: 11:22:44, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR.

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TOS, NIEGA OTROS SINTOMAS

Objetivo:

FC: 76 FR: 19 TA: 104/87 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FOBROBRONCOSCOPIA

Fecha: 19/05/2022: 11:55:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR.

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TOS, NIEGA OTROS SINTOMAS

Objetivo:

FC: 76 FR: 19 TA: 104/87 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FOBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION.

Fecha: 20/05/2022: 10:53:13, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TOS, NIEGA OTROS SINTOMAS

Objetivo:

FC: 76 FR: 19 TA: 104/87 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARACLINICOS BACILOSCOPIAS NEGATIVAS X3

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FOBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION.

Fecha: 21/05/2022: 09:37:04, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** DIEGO MORENO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR. 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA DE LA DISNEA, NIEGA NAUSEAS, VOMITOS Y OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

FC: 81 FR: 21 TA: 112/80 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FOBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION.

Fecha: 23/05/2022: 10:02:14, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR.

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE TOS, NIEGA DISNEA U OTROS SINTOMAS

Objetivo:

FC: 81 FR: 21 TA: 112/80 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FOBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION.

Fecha: 24/05/2022: 10:05:50, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

PACIENTE NIEGA SÍNTOMAS

Objetivo:

FC: 81 FR: 21 TA: 112/80 SO2: 96 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTIONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FIBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION, FECHA TENTATIVA MAÑANA, SE SOLICITA ANTIGENO PARA SARS COV 2 Y SE ACTUALIZAN PARA CLINICOS.

Fecha: 25/05/2022: 10:35:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A DESCARTAR

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

NIEGA SÍNTOMAS

Objetivo:

FC: 70 FR: 15 TA: 112/80 SO2: 98 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTIONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, POR LO QUE SE SOSPECHA TUBERCULOSIS, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA NEUMOLOGIA SOLICITO FIBROBRONCOSCOPIA, PENDIENTE REALIZACION, PROGRAMADA PARA EL DIA DE HOY, PACIENTE ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 26/05/2022: 06:03:46, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA DISNEA, TOS, MALESTAR GENERAL U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

FC: 70 FR: 15 TA: 112/80 SO2: 98 PESO: 41 KG

PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTIONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

PARACLINICOS: 25/05/2022 BACILOSCOPIA: POSITIVO, SE OBSERVAN 1 A 9 BAAR KOH: NEGATIVO GRAM: NEGATIVO PENDIENTE : CULTIVO PARA HONGOS, CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM, ANTIBIOGRAMA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE INGRESA CON CUADRO DE TOS CRONICA Y HEMOPTISIS, CON TABICACIONES EN ESTUDIOS DE IMÁGENES, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA SE REALIZA FIBROBRONCOSCOPIA DONDE SE APRECIA POR TINCION DE ZIEHL NEELSEN BARR, POR LO QUE SE CONFIRMA INFECCION POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR LO QUE EL DIA DE HOY SE REDACTA FICHA DE NOTIFICACION Y SE INDICA INICIO DE TERAPIA RIPE EN FASE INTENSIVA, PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR, CONTINUA HOSPITALIZADA PARA VERIFICACION DE TOLERANCIA AL TRATAMIENTO, PACIENTE ENTIENDE Y ACEPTAR.

Fecha: 27/05/2022: 08:53:49, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA OTROS SÍNTOMAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVAEPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

Objetivo:

FC: 70 FR: 15TA: 112/80 SO2: 98 PESO: 41 KG PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO. PARA CLINICOS: 25/05/2022 BACILOSCOPIA: POSITIVO, SE OBSERVAN 1 A 9 BAAR KOH: NEGATIVO GRAM: NEGATIVO PENDIENTE : CULTIVO PARA HONGOS, CULTIVO PARAMYCOBACTERIUM, ANTIBIOGRAMA

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA PENDIENTE INICIO DE TERAPIA RIPE EN FASE INTENSIVA, PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 28/05/2022: 09:44:40, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX: 1. INFECCION RESPIRATORIA 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR

Objetivo:

FC: 83 FR: 15TA: 112/80 SO2: 98 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA PENDIENTE INICIO DE TERAPIA RIPE EN FASE INTENSIVA, PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 29/05/2022: 08:40:07, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA SINTOMAS

Objetivo:

FC: 90 FR: 16 TA: 120/80 SO2: 99 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, SE LE INICIO TERAPIA RIPE AYER EN LA NOCHE, A LA ESPERA DE VERIFICAR TOLERANCIA

Fecha: 30/05/2022: 06:39:15, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIE, NIEGA NAUSEAS, VOMITOS, MALESTAR GENERAL U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

FC: 80 FR: 17 TA: 110/70 SO2: 99 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NAALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑOPERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:19:25 p. m.

Admisión: AD736482

Administradora: NUEVA EPS

Paciente: ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ

EPICRISIS

EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, SE LE INICIO TERAPIA RIPE, A LA ESPERA DE VERIFICAR TOLERANCIA PARA CONSIDERAR MANEJO AMBLATORIO POR LO QUE SE SOLICITA PARACLINICOS CON CONTROL DE AZOAFOS Y FUNCION RENAL SE EXPLICA A PACIENTE, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 31/05/2022: 07:40:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON IDX:

1. INFECCION RESPIRATORIA

1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

2. HIPERTENSION ARTERIAL POR HISTORIA CLINICA

Subjetivo:

NIEGA SINTOMAS

Objetivo:

FC: 90FR: 15 TA: 120/80 SO2: 99 PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, EN BUENAS CONDICIONES MUSCULO NUTRICIONALES, ECTOMORFICO, CONSCIENTE, ALERTA ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS, NORMOCEFALO, ESCLERAS ANICTERICAS PUPILAS ISOCORICAS, REACTIVAS A LA LUZ, FOSAS NASALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HUMEDA, SIN HIPEREMIA NI SECRECIONES, NO OTORREA, CUELLO MOVIL, SIN MASAS, NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR, TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, BIEN TIMBRADOS, SIN SOPLOS NI AGREADOS, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, ABDOMEN DEPRESIBLE, PERISTALSIS CONSERVADA, TIMPANICO, NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS NI VISCEROMEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERTONEAL, PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA, EXTREMIDADES EUTROFICAS, SIMETRICAS, SIN PRESENCIA DE EDEMA NI LESIONES, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS, GENITOURINARIO NO EXPLORADO.

PARACLINICOS: TP: 11.6 CONTROL: 10.6 .TPT: 27.6 CONTROL: 25.5

BILIRRUBINA TOTAL: 0.44 AST: 26 ALT: 14 BUN: 23 CREA: 1.12

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA SEPTIMA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, EN EL MOMENTO EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE Y VIA ORAL, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, NI DATOS CLINICOS DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EN EL MOMENTO, VIA AEREA PERMEABLE, LA PACIENTE NO CUENTA CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO TERAPIA SUPLEMENTARIA, SE INICIO TERAPIA RIPE, HASTA AL MOMENTO TOLERANDO TERAPIA, SIN COMPROMISO HEPATICO O RENAL POR LO QUE SE DA EGRESO CON TERAPIA RIPE, CITA CONTROLES Y SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES SE INDICA INICIAR EN PROGRAMA DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS, RECLAMAR CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM AMBULATORIO, SE EXPLICA A PACIENTE, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

NINGUNA

Servicio de Egreso: 000001|Urgencia

Fecha de Egreso: 31/05/2022 07:47

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A150 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO

Diagnóstico Relacionado 1: J180 : BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

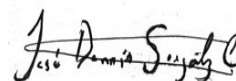
RIPE 3 COMPRIMIDOS VIA ORAL CADA 24 HORAS POR DOS MESES FI: 29/05/2022

ACETAMINOFEN TAB 500 MG DAR 1 GRAMO VIA ORAL PRN

Recomendaciones Adicionales:

P/P CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RECLAMAR AMBULATORIO CITRAC ONTROL POR MEDICINA INTERNA CITA CONTROL POR MEDICINA GENERAL INGRESAR A PROGRAMA DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DE SU EPS SE DAN SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES

Aplica Cuidados de Enfermería: No



JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO
MEDICINA INTERNA

CC.73139025 - RM.CC:73139025 - RM:1463

INFORMACIÓN GENERAL**Fecha de Impresión:** 07/09/2026 3:19:25 p. m.**Admisión:** AD736482**Administradora:** NUEVAEPS**Paciente:** ENRIQUETA DEL CARMEN GARCIA DE SUAREZ**EPICRISIS**